

Examen ORL de base

Atelier
1^{ère} Master

Pour CEC

06/07/12/13 novembre 2024

Séminaire : examen ORL de base				IuMFE	
Jour	Date	Groupe	horaire	salles (2 heures)	Enseignant-e (2 heures)
MERCREDI	06.11.2024	5	14h15-16h00	B04.1712	Stéphane Bernard
		6		B04.1713	Luis Rayo
		7		B04.1715	Y-C Cottier
		8		B04.1411	Eliane Zeukeng
JEUDI	07.11.2024	9	10h15-12h00	B04.1520	Gabriel Brändle
		10		B04.1522	Luis Rayo
		11		A04.2706	Eliane Zeukeng
		12		A04.2910	Laurent Nyffenegger
MARDI	12.11.2024	13	13h15-15h00	B00.0612	Cédric Gillabert
		14		B00.0614	Alessandro Diana
		15		B00.0615	Nicolas Perone
		16		B00.0617	Isabelle Gerard
MERCREDI	13.11.2024	1	13h15-15h00	B00.0612	Martine Bideau
		2		B00.0614	Y-C Cottier
		3		B00.0615	Nicolas Perone
		4		B00.0617	Gaspard Aebischer

Objectifs généraux

Au terme de ce cours les étudiant-es seront capables de:

De faire le lien entre l'anatomie de la sphère ORL et les principaux signes et symptômes de la sphère ORL

D'utiliser certains instruments de base utilisés en ORL

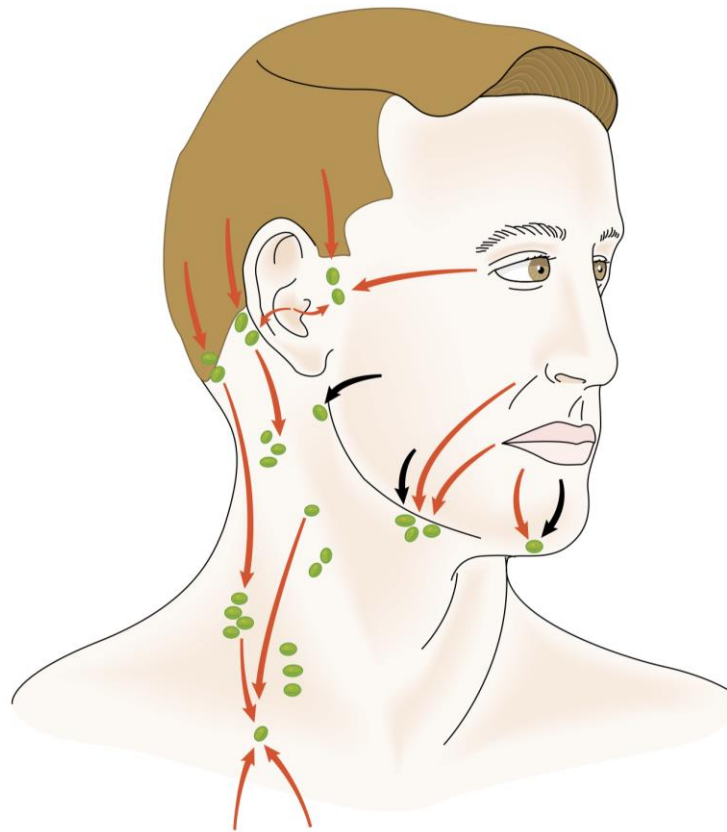
De réaliser l'examen clinique ORL de base: [L][SEP]

- examen de la face et de la région cervicale [L][SEP]
- examen de la cavité buccale, de l'oro-pharynx et du nez
- examen du CAE et du tympan avec l'otoscope [L][SEP]
- acoumétrie clinique et test de Rinne / Weber

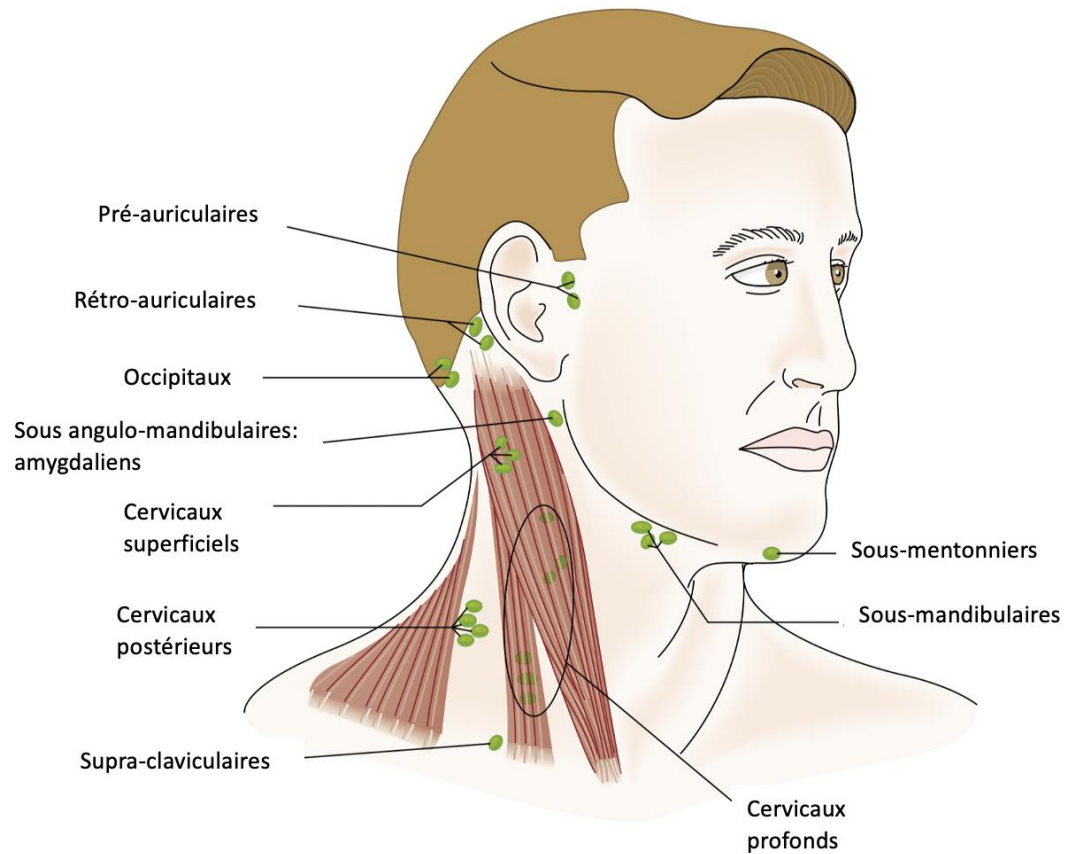
<https://www.profilesmed.ch/>



Les aires ganglionnaires



External lymphatic drainage
Internal lymphatic drainage (e.g., from mouth and throat)



Ganglion ou adénopathie¹ ?

Grosseur palpable dans une aire ganglionnaire:
physiologique ou adénopathie ?

Les critères principaux à considérer:

1. Taille: < 1cm dans la longueur
2. Forme: ovale et régulière
3. Localisation: unique, aire unique, disséminé
 - sous-mandibulaire ou inguinale = fréquente
 - sus-claviculaire = néoplasie
4. Nature du ganglion: ferme/molle, mobile (plan superficiel et profond), sensibilité/douleur.
5. Nature du tissu avoisinant: infection localisée cutanée, ORL
6. Mode d'apparition et évolution:
 - Aigu: 1 à 2 semaines, sinon subaigu ou chronique
 - Règle des 7*: «un nodule apparu il y a moins de sept jours est a priori inflammatoire, un nodule évoluant depuis environ sept semaines est a priori tumoral, et un nodule présent et non évolutif depuis plus de sept mois correspond à une pathologie bénigne»
7. Autres symptômes ou signes cliniques: voyage, piqure, splénomégalie
8. Patient: âge, maladie systémique.

Tableau 1. Critères d'orientation entre ganglion et adénopathie

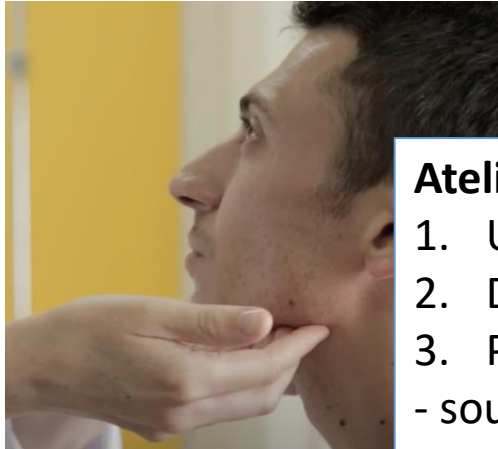
	Ganglion	Adénopathie
Taille	< 1 cm	> 1 cm
Forme	Ovale, régulière	
Localisation	• Sous-mandibulaire • Inguinale	• Epitrochléenne • Sus-claviculaire

¹Source: Dr J'ai un ganglion, Rev Med Suisse 2009 ; 5 : 710-5

*RMS 2004;124: 361-6 Grosjean et Monnier

Atelier 1: Palpation des aires ganglionnaires

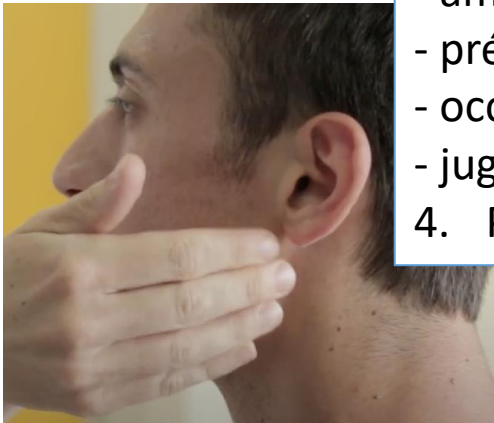
Réf. iCAP Université Claude Bernard Lyon 1



Sous-maxillaire



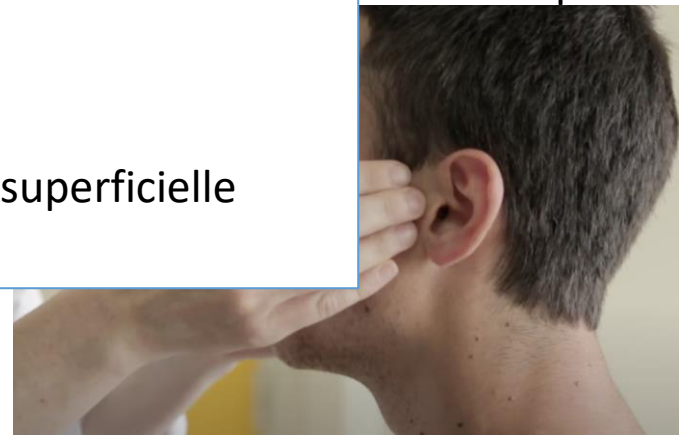
Occipitale



Amygdalienne



Jugulo-carotidienne

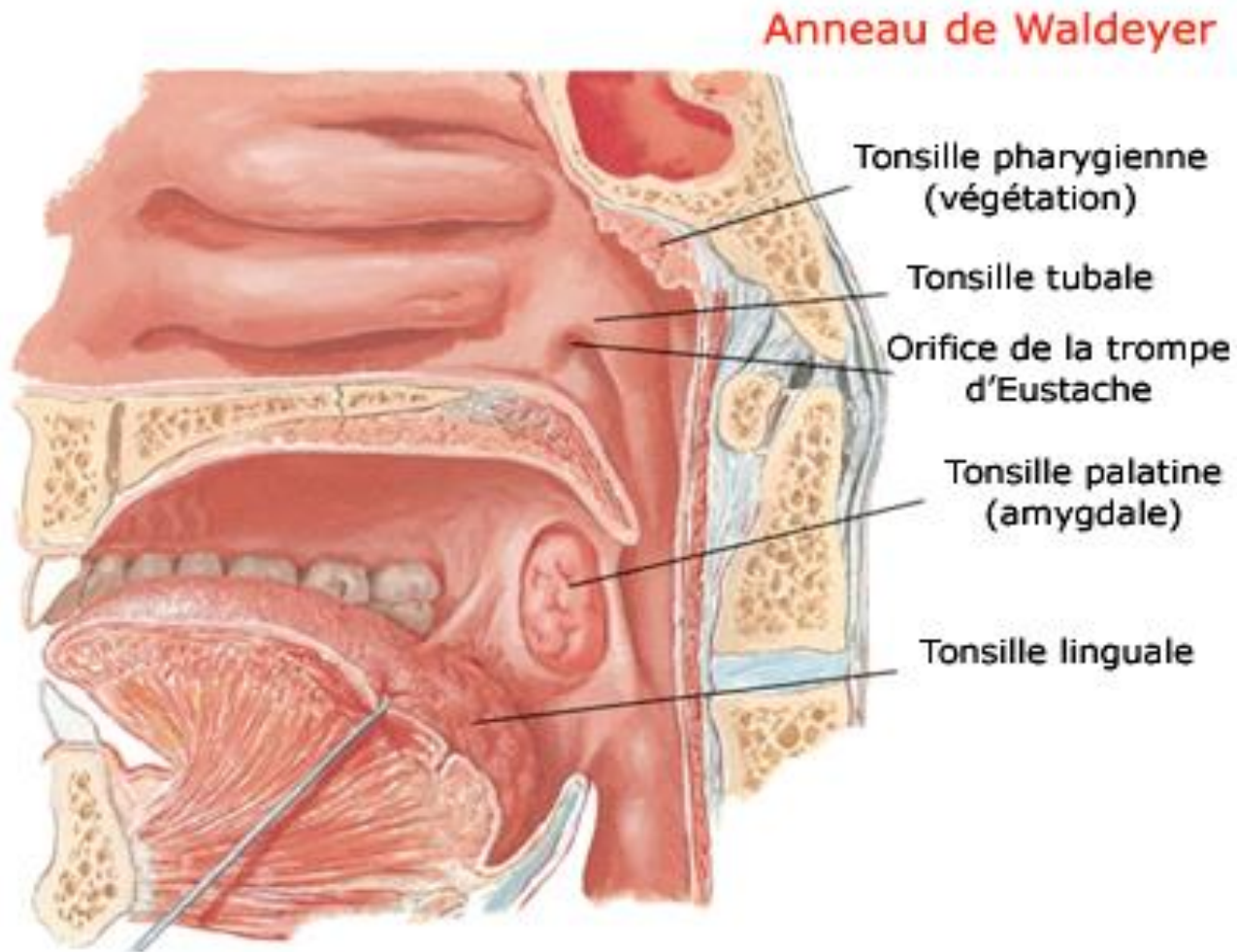


Pré-auriculaires

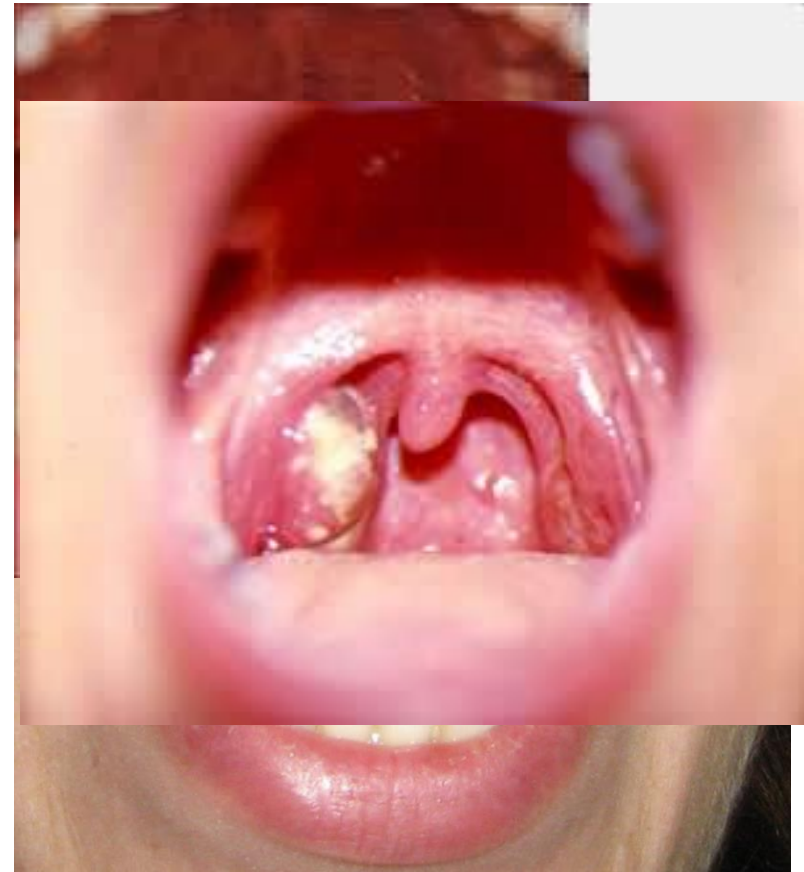
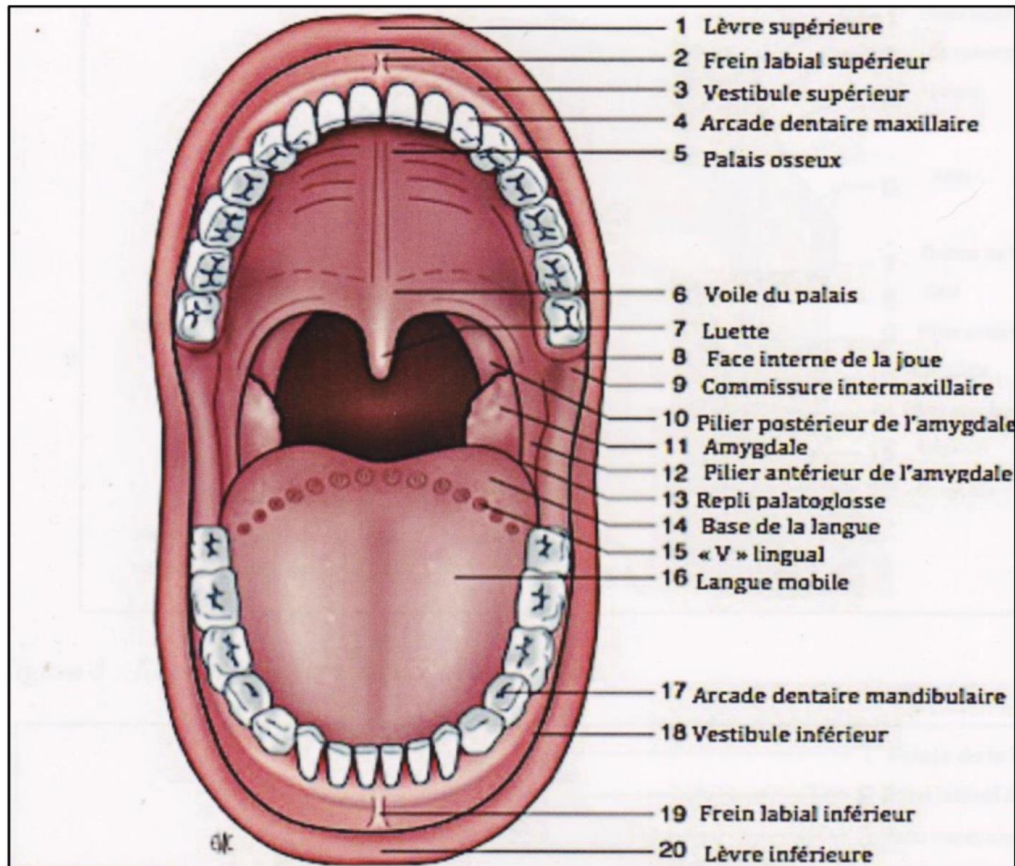
Atelier

1. Un-e médecin et un-e patient.e
2. Désinfection des mains
3. Palpation des aires ganglionnaires:
 - sous-maxillaires
 - sous-mentonnières
 - amygdaliennes
 - pré-auriculaires
 - occipitales
 - jugulo-carotidienne = cervicale superficielle
4. Puis on échange les rôles

Anneau de Waldeyer

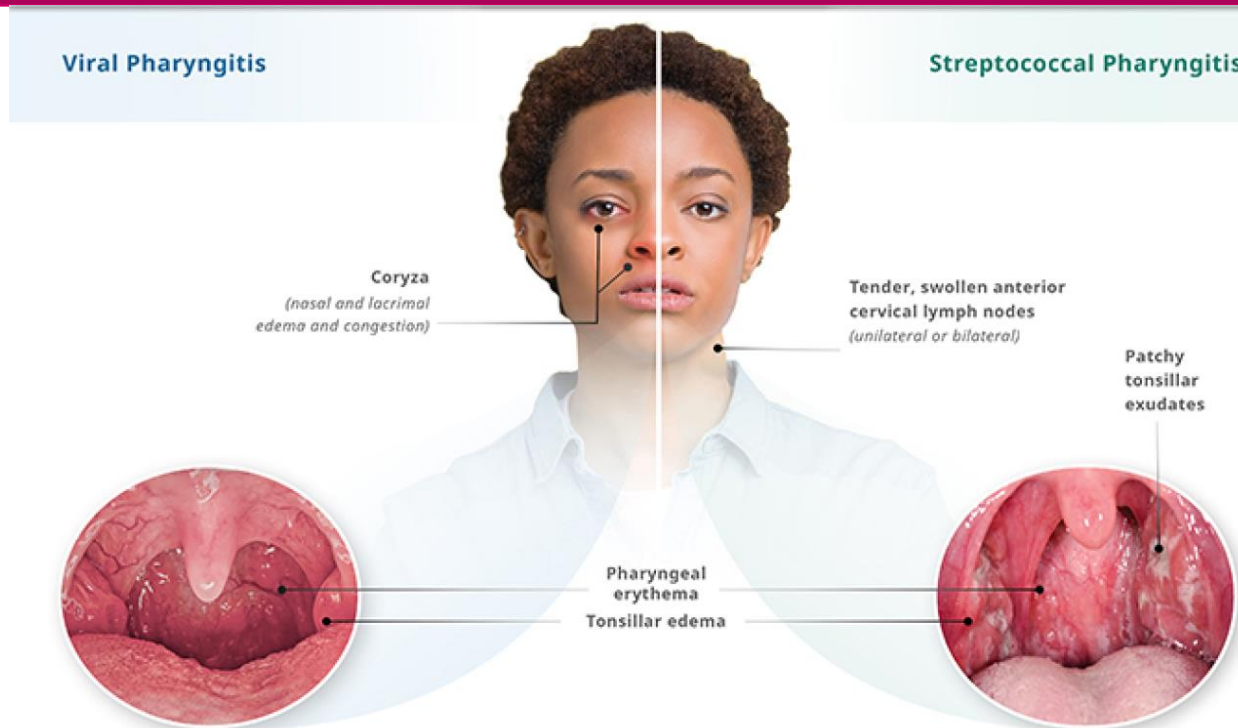


Cavité buccale (et oropharynx)



Réf. Figure 1: Cavité orale, vue antérieure (source EMC).

Pharyngite aiguë: virale ou bactérienne



	Pharyngite virale	Pharyngite à streptocoques
Symptômes respiratoires associés	Toux, rhinite, conjonctivite, laryngite	absents
Fièvre	basse ou absente	présente
Maux de gorge, apparition	subaigu	aiguë
Cavité buccale	Ulcères	Pétéchies, exsudats amygdaliens, langue de fraise
Peau	Exanthème viral	Rash scarlatiniforme
Adénopathies	cervicales peu importantes	sous-mandibulaire, unilatérale

Diagnostic des agents pathogènes selon Score de Centor (enfants & adultes)

Un point pour chaque critère présent:

- Absence de toux
- Exsudats amygdaliens
- Histoire de fièvre ou température > 38°C
- Adénopathie cervicale antérieure sensible



0-2 points au score de Centor: pas de frottis, pas de traitement

3-4 points au score de Centor: faire TDR du streptocoque du groupe A si une ABtt est envisagée.

Ne pas faire de culture du frottis de gorge

Prise en charge:

- **Observer sans antibiotiques** (possible en cas de pharyngite causée par streptocoque du groupe A)

- **Adultes:** Pénicilline V 1 Mio U.I./12h per os, 6 jours ou Amoxicilline 1g /12h per os, 6 jours

- Allergie non sévère à la pénicilline: cefuroxime 500mg /12h per os, 6 jours
- Si CI aux bêta-lactamines: clarithromycine 500mg /12h per os, 6 jours

- **Enfants:** Amoxicilline per os 25mg/kg/12h per os, 6 jours

- Allergie à la pénicilline, céphalosporines : cefuroxime 15mg/kg/12h per os, 6 jours
- Si CI absolue à l'ensemble des bêta-lactamines: clindamycine 7 mg/kg/8h per os, 6 jours



The Quick 5-Phase Oral Mech Exam
CHARLOTTE BOSHART | 03-2019

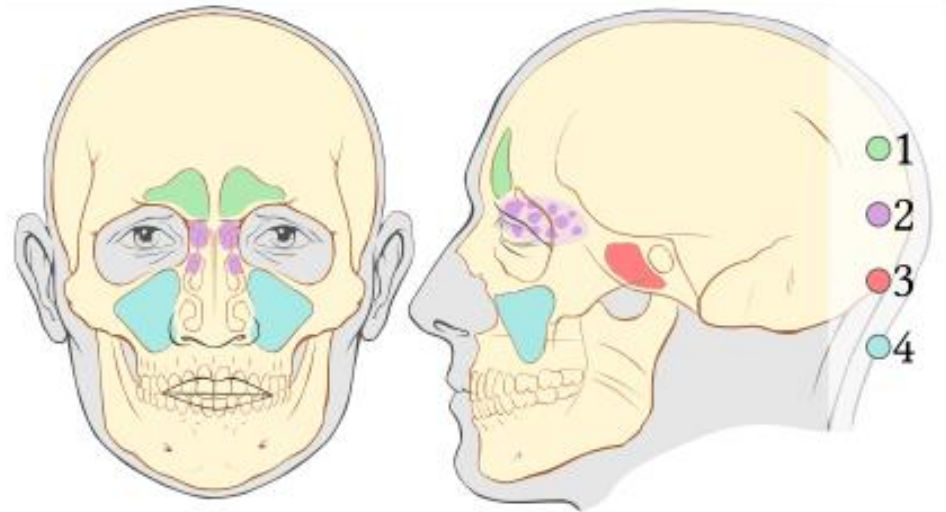
Atelier 2: Examen de la cavité buccale

En binôme

- Désinfection des mains
- Le patient est assis, le médecin est en face
- Le médecin demande au patient d'ouvrir la bouche
- Avec la lampe regarder les structures
- Au besoin demander au patient de dire «AAA»
- Au besoin utiliser l'abaisse-langue en le posant sur la partie antérieure de la langue et appuyant vers le bas
- Désinfection des mains

Les sinus paranasaux

1. Frontaux
2. Ethmoïdaux
3. Sphénoïdaux
4. Maxillaires



Fonctions

Réchauffement de l'air
Caisses de résonance
Régulateurs des muqueuses
Stabilisateurs du poids du crâne

Atelier 3: Examen des sinus

Health & Physical Assessment in Nursing, Third Edition
Donita D'Amico | Colleen Barbarito

Sinusite aiguë

- Douleurs augmentées en se penchant en avant
- Rhinite purulente
- Fièvre
- Tuméfaction visage
- Douleurs dentaires (sinusite max.)

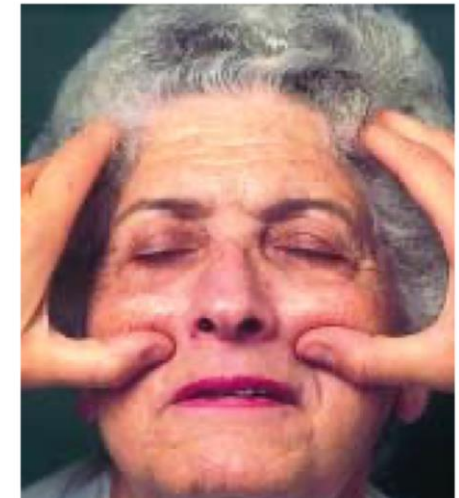
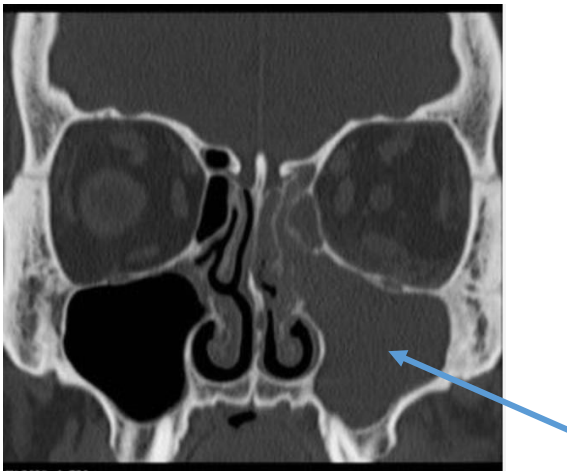


Sinus frontaux

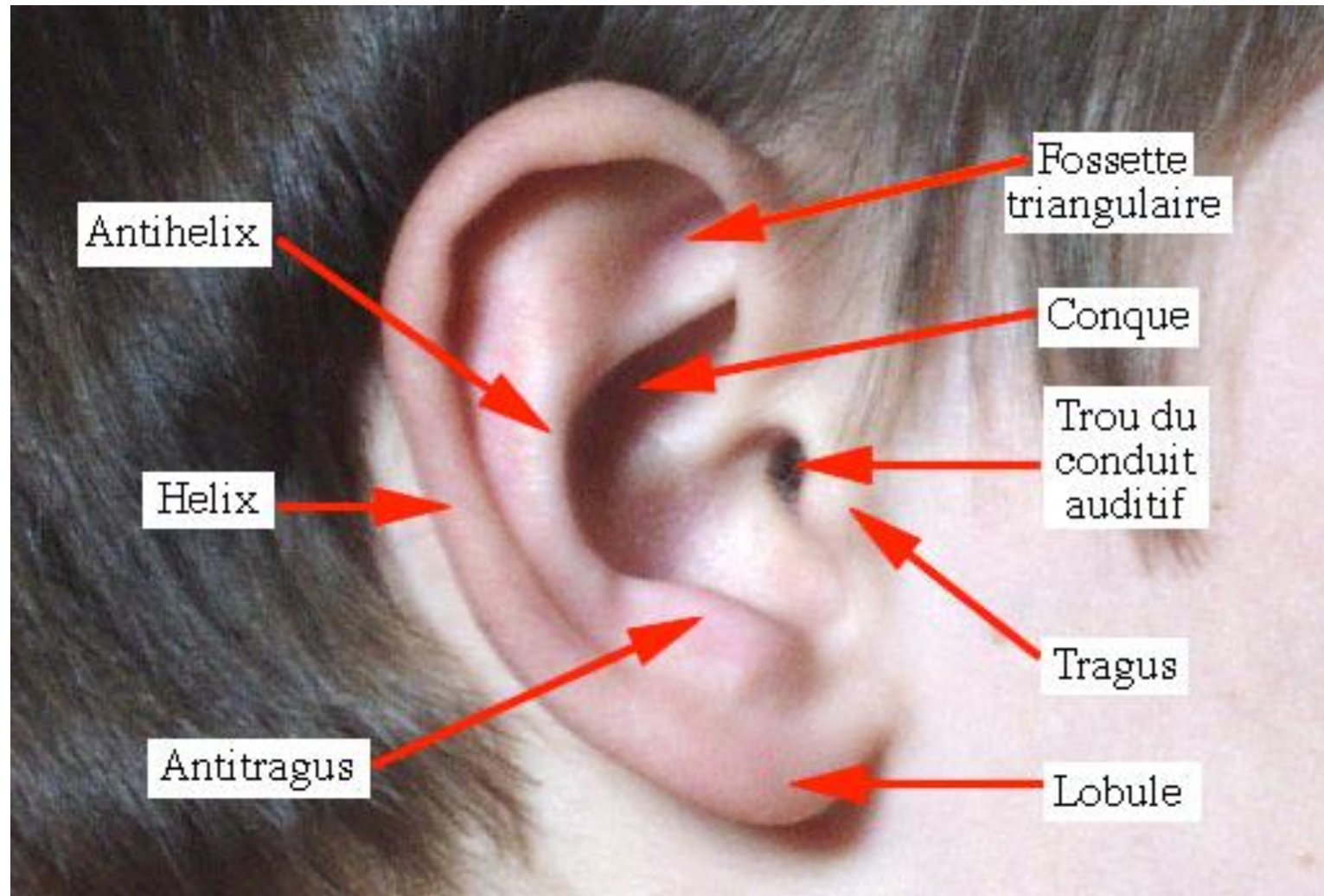


Sinus maxillaires

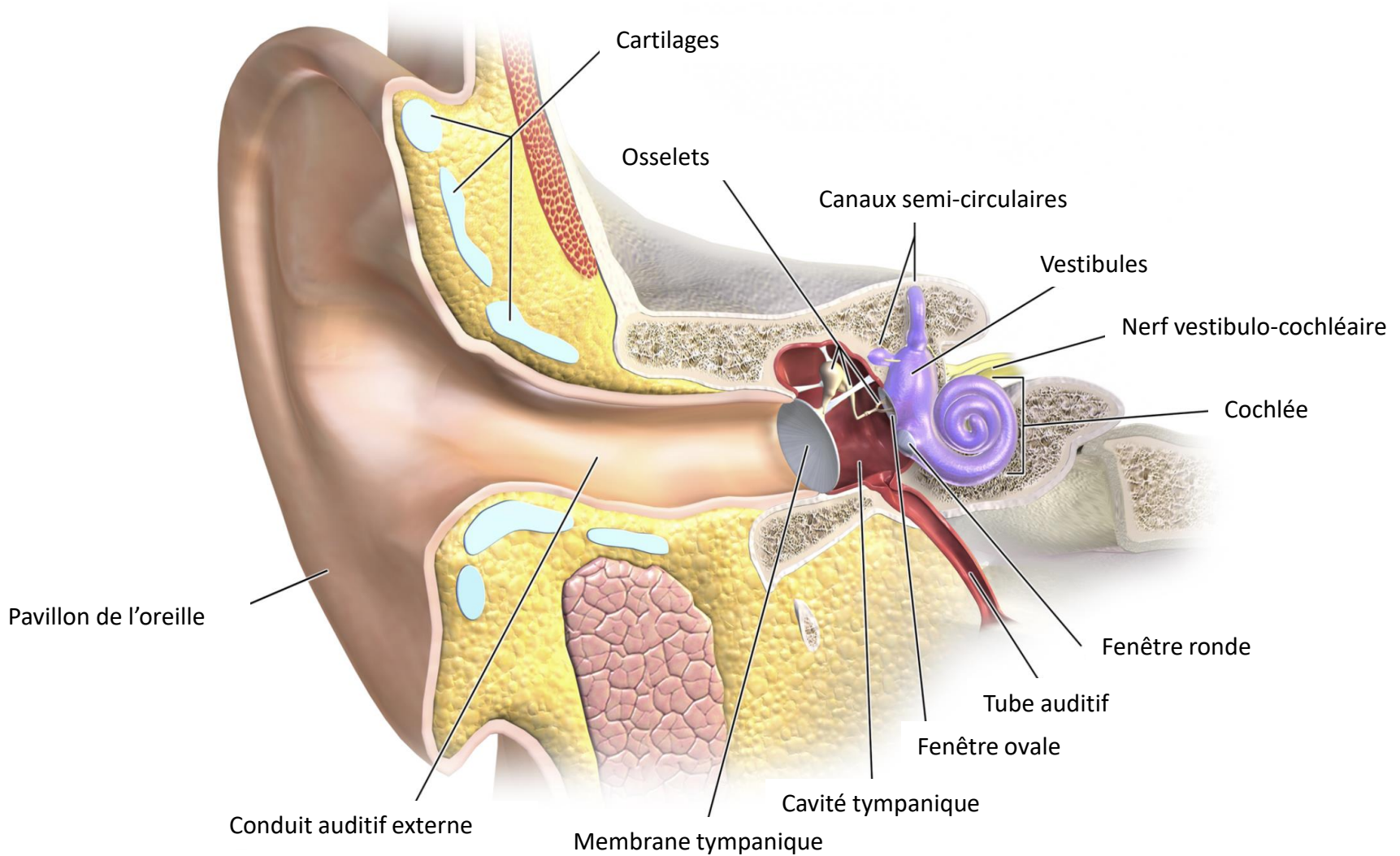
Sinusite maxillaire



L'oreille externe



Conduit auditif externe et tympan



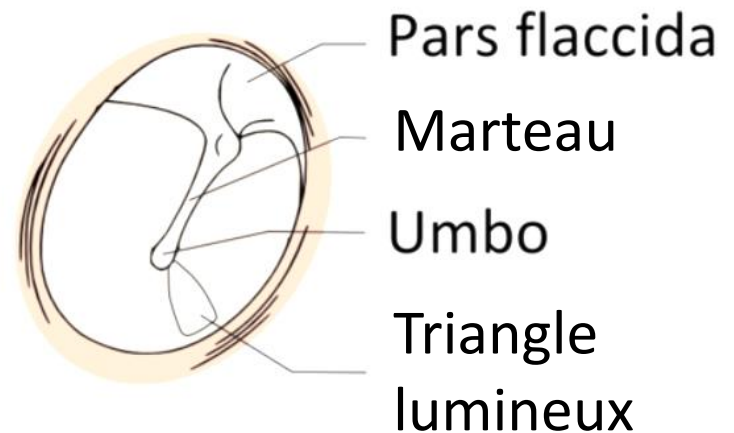
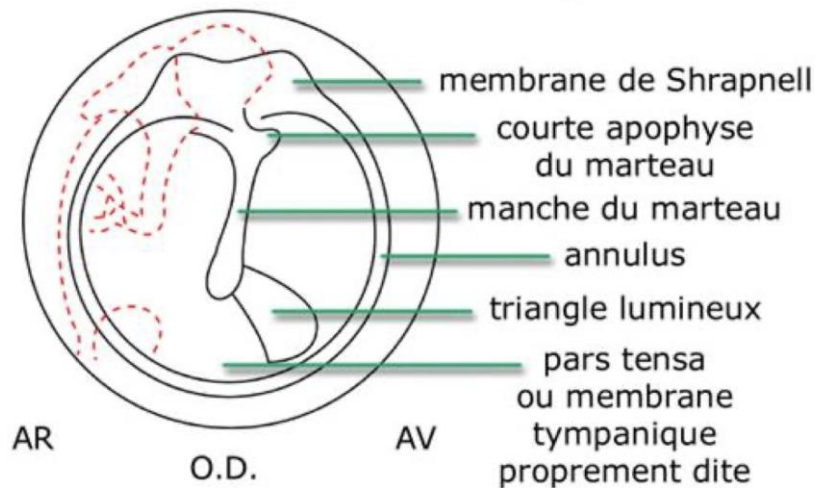
Anatomie du tympan

Doit être vu dans son intégralité. Il doit être intègre (non perforé), légèrement rosé et transparent, sans rétention liquidienne visible à travers lui.

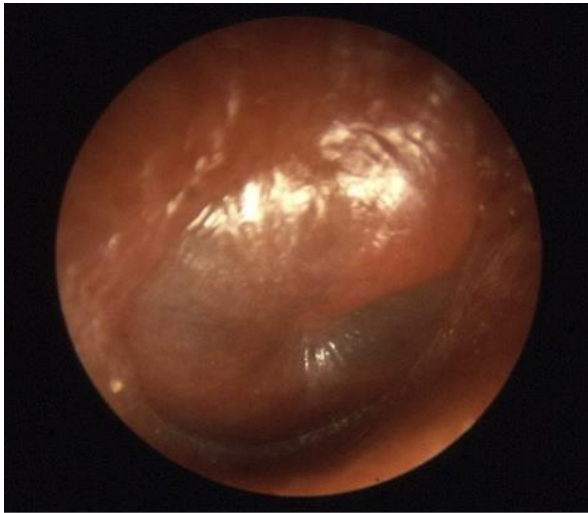
- Le tympan est centré par le manche du marteau
- La partie supérieure du marteau: relief de cet osselet visible = apophyse externe.
- Le manche du marteau, visible.
- Le reflet de la lumière de l'otoscope = triangle lumineux, antérieur.

Anatomie du tympan droit

Ce que l'on voit



Otite moyenne aiguë et séreuse



Otite moyenne aiguë



Otite moyenne aiguë



Otite séreuse

Atelier 4 classique: Otoscopie

Utilisation de l'otoscope:

1. Traction du pavillon en arrière et en haut
2. Otoscope dans l'autre main:
 - position oblique de l'otoscope
 - petit doigt contre le visage
 - spéculum vers l'avant et le haut
3. Spéculum au début du conduit
4. On se penche, on oriente l'otoscope sans le faire rentrer plus en avant: Cave tympan !
5. On observe le conduit auditif externe et le tympan



Atelier 4 Peyton: Otoscopie

Les 4 étapes de l'enseignement des compétences pratiques :

1. Démonstration réaliste - le formateur démontre la compétence à une vitesse normale sans commentaire.
2. Exposé du formateur - le formateur répète la procédure tout en expliquant chaque étape et manœuvre
3. Exposé de l'apprenant - le stagiaire dirige le formateur en lui donnant des instructions sur chaque étape et manœuvre pendant que le formateur exécute la compétence.
4. L'apprenant exécute - le stagiaire exécute la compétence sous une supervision étroite, en décrivant chaque action avant qu'elle ne soit exécutée.

1. Démonstration “réaliste” : 1er étape

Un patient: étudiant A

L'apprenant: étudiant B

Le formateur: Chargé de cours

Le patient s'assied, l'apprenant à coté regarde le formateur

Les autres étudiants se mettent autour et observent

Le formateur démontre la compétence à une vitesse normale sans commentaires. (vidéo suivante)

Cela permet aux stagiaires d'observer la maîtrise de la compétence.



2. Exposé du formateur (déconstruction)

Le formateur répète la procédure en expliquant chaque étape et chaque manœuvre,

- lentement,
- en répondant aux questions des étudiants,
- en clarifiant certains points.

Ou bien,

on illustre avec la vidéo (prochaine diapo) qui peut être interrompue pour des questions.

Queen's

Meds 115: Family Medicine

MJ Sylvester MD MEd FCFP

Ear Pain 5: Otoscope Examination

September, 2013

3. Exposé de l'apprenant (compréhension)

L'apprenant dirige le formateur, à effectuer le geste sur l'étudiant A:

- en lui donnant des instructions précises
- chaque étape déconstruites comme pour la partie précédente
- le formateur exécute les consignes

Check-list:

- comment se tenir face au patient
- explication au patient: « je vais examiner....»
- comment tenir l'otoscope dans sa main: main droite pour oreille droite
- tirer sur le pavillon en arrière et vers le haut
- bord de la main/auriculaire droit contre la joue du patient
- garder speculum à distance du tympan
- on bouge l'otoscope et on suit le mouvement avec la tête
- on décrit ce que l'on voit
- on fait la même chose de l'autre côté avec l'autre main

4. L'apprenant exécute (performance)

En binômes, les étudiants effectuent le geste en répétant la troisième partie.

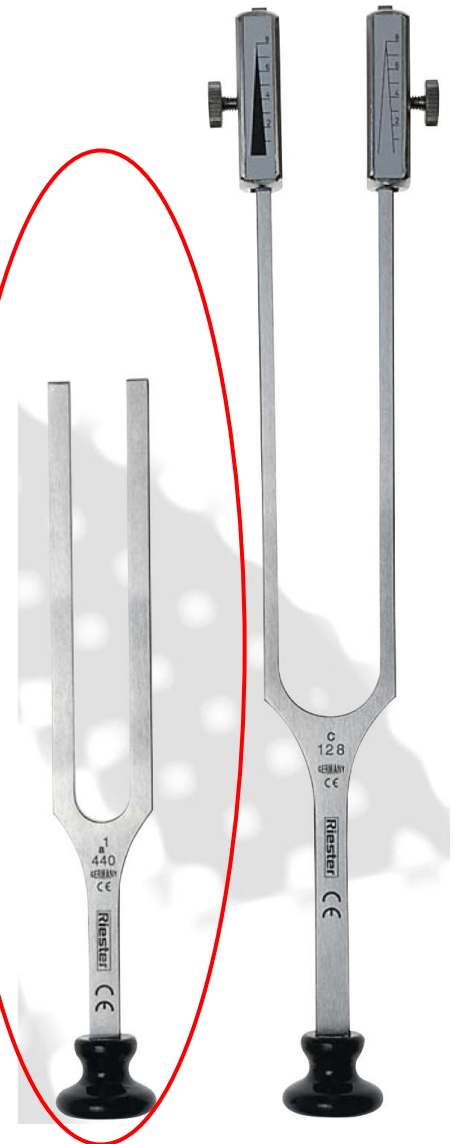
Le formateur passe vers les binômes pour répondre aux questions et aider au geste

Atelier 5: L'audition

Acuité auditive:

- Testez une oreille à la fois.
- Demandez au patient d'obstruer une oreille avec un doigt.
- à 20 cm de distance, chuchotez doucement vers l'oreille non occluse.
- Choisissez des nombres ou d'autres mots avec deux syllabes
- Si nécessaire, augmentez l'intensité de votre voix à un murmure moyen, un murmure fort, puis une voix douce, moyenne et forte.

Si l'audition est diminuée, essayez de faire la distinction entre la perte auditive conductrice et neurosensorielle. Utiliser un diapason, de préférence de **512 Hz** ou **éventuellement 1024 Hz**



L'audition: Test de Rinne

Si l'audition est diminuée, comparez la conduction aérienne et osseuse:

Mettez le diapason en vibration

1. Placer la base du diapason légèrement vibrant sur l'os mastoïde, lorsque le patient n'entend plus le son,
2. le placez rapidement près du conduit auditif et vérifiez si le son peut être à nouveau entendu.

Si le son est à nouveau entendu:

test de Rinne positif

= **Surdité de perception**

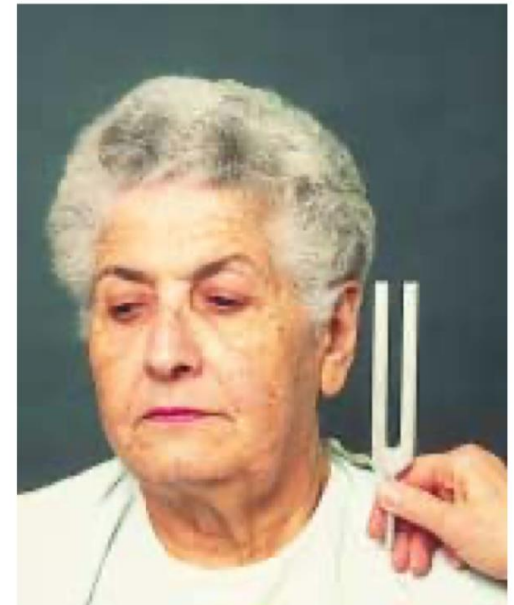
Si le son n'est pas entendu:

test de Rinne négatif

= **Surdité de transmission**



1. Conduction osseuse



2. Conduction aérienne

L'audition: Test de Weber

Test de latéralisation, **test Weber**.

- Mettez la diapason en vibration
 - Placer fermement la base du diapason sur le milieu de la tête:
 1. Normalement, le son est entendu dans la ligne médiane ou également dans les deux oreilles.
 2. Si asymétrie = latéralisation
- Test de Weber latéralisé du côté « le plus fort »

Surdit  de perception:

Lat ralisation du cot  sain

Surdit  de transmission

Lat ralisation du cot  malade



Questions ?



luMFE: nicolas.perone@unige.ch